

• 药物与临床 •

药物相互作用

四、中枢抑制药	处 理
巴比妥类 - 口服抗凝药、口服避孕药、雌激素、皮质激素、三环抗抑郁药、洋地黄类(包括地高辛)、奎尼丁、茶碱及其他经肝代谢药物:巴比妥类可诱导肝微粒体酶,促进这些药物的代谢和首过作用,使之降效。 - 碳酸氢钠:使尿碱化、促进巴比妥类的尿排泄,使之降效。此作用可用于解救巴比妥类中毒。 - 苯妥英钠:药效学上两者作用相加;药物动力学方面两者的代谢均可加速,出现复杂的相互作用。 - 中枢抑制药、乙醇、全麻药、单胺氧化酶抑制药:药效相加。 苯二氮革类 - 中枢抑制药:中枢抑制作用加强。 - 抗高血压药、利尿降压药:降压作用增强。 - 抗酸药:苯二氮革类口服吸收减少。 - 利福平:苯二氮革类消除加速。 - 西咪替丁、红霉素、口服避孕药等:苯二氮革类消除减慢,对劳拉西洋影响小。 - 卡马西平:两者的代谢均加速,血药浓度低于正常。 - 普萘洛尔:普萘洛尔代谢加速。 - 左旋多巴:疗效下降。 苯妥英钠 - 肾上腺皮质激素、雌激素(口服避孕药)、环孢素、洋地黄类、左旋多巴、奎尼丁、口服降糖药、胰岛素等:代谢加速降效。 - 卡马西平:代谢加速、血药浓度降低。 - 苯巴比妥、扑米酮:作用相加,但血浓度两者均降低(参见巴比妥类)。 - 利多卡因、普萘洛尔:苯妥英钠静注可致心脏抑制加重。 - 对乙酰氨基酚、异烟肼:代谢加速,肝脏毒性加强。 - 口服二、三价金属制酸药:苯妥英钠吸收减少。 - 乙醇:嗜酒者,苯妥英钠代谢加速,但在急性中毒(醉酒)时,代谢反减慢。 卡马西平 - 口服抗凝药、雌激素(口服避孕药)环孢素、洋地黄苷(地高辛可除外)奎尼丁、四环素类等:由于卡马西平的酶促进作用,使这些药物的代谢加速,血药比正常时降低。 - 对乙酰氨基酚:代谢加速、肝毒性可增强。 - 红霉素、竹桃霉素、右丙氧芬:抑制卡马西平代谢,毒性可增强。 - 中枢抑制药:增强中枢抑制。 - 单胺氧化酶抑制药:可引起高热、高血压危象,并可改变癫痫发作类型。 - 碳酸酐酶抑制剂(乙酰唑胺等):长期应用可致钙丢失,增加骨质疏松。 扑米酮 本品具有苯巴比妥类似结构,具有苯巴比妥的类似酶诱导作用和中枢抑制作用,参见巴比妥类。 - 单胺氧化酶抑制剂:抑制扑米酮代谢,血药浓度升高,可出现中毒。 - 维生素 C:肾排泄增加。	避免联用 注意 注意、肝功能受损者应谨慎 需调整剂量 注意用量 分别服用 注意 应监测调整剂量 心电监测 间开服用 应戒酒 必要时应监测、加强观察,调整药量 临床观察并检验,必要时监测 宜谨慎 两类药应间隔 14 日 应警惕及时停用 避免联用 增加剂量

- 维生素 D: 代谢加快。
- 维生素 B₁₂: 肠道吸收减少。
- 卡马西平: 两药代谢消除均加快。
- 丙戊酸: 竞争蛋白结合使代谢减慢, 使卡马西平血浓度升高。

丙戊酸类

- 中枢抑制药: 中枢抑制作用加强。
- 苯巴比妥: 苯巴比妥的代谢受阻, 作用强度和时效均增大(扑米酮有类似的相互作用)。
- 口服抗凝药、溶栓药、抗血小板药: 这些药物的效应均增强, 可致出血。
- 苯妥英: 竞争蛋白结合, 苯妥英血浓度上升。
- 卡马西平: 由于酶诱导, 两者的血浓度及半衰期均减低。
- 肝毒性药物: 加重肝毒性。

氯硝西泮

- 中枢抑制药: 中枢抑制作用加强。
- 卡马西平: 两药的代谢均加快。
- 三环抗抑郁药: 中枢抑制加强, 但抗惊厥疗效反可降低。
- 左旋多巴: 抗震颤麻痹作用减弱。
- 丙戊酸: 少数病例可发生失神持续状态。

注意

注意

剂量调整

注意减量

减量应用

监测凝血功能

监测苯妥英

监测调整用量

监测肝功能

减量

监测调整用量

注意不可联用

一般不可联用

注意, 谨慎

复方乳酸钠注射液临床配伍简析

刘 勇

复方乳酸钠注射液又称平衡液, 为电解质补充药, 被临床医生广泛用于腹泻、手术前后、烧伤、烫伤、外伤出血、骨折、严重感染、重症糖尿病昏迷及肾炎等引起的脱水及酸中毒等的治疗。平衡液为复方灭菌无色透明水溶液, 含有乳酸钠、氯化钠、氯化钾与氯化钙, pH 为 7.5~8.5, 偏碱性, 易与许多药物发生配伍反应, 主要反应如下。

1 复方乳酸钠注射液偏碱性不能与强酸性药物配伍; 不能用于碱中毒者。如配伍可使溶液 pH 值改变幅度较大, 或者使酸性药物分解失效, 副作用增大等, 如与维生素 C 酸离子与氢氧根离子反应生成水。

2 复方乳酸钠注射液含 Ca²⁺, 不能和与 Ca²⁺起反应的药物配

伍, 否则易引起沉淀, 或引起其他不良反应; 如与碳酸盐反应生成碳酸钙沉淀; 与硫酸盐反应生成硫酸钙沉淀; 与磷酸盐反应生成磷酸钙沉淀。这些药物的许多剂型包括间接使用也要慎用; 另外, 不能在输血时与枸橼酸钠和血液混合使用。

3 复方乳酸钠注射液含 K⁺, 对心力衰竭、对 K⁺排泄不良者禁用。

4 复方乳酸钠注射液含 Na⁺, 对肾功能不全及肝功能不全者慎用。

5 复方乳酸钠注射液不易与某些含活性成分的药物配伍, 如辅酶 A、脑水解蛋白质、二磷酸果糖等。

另外, 大量使用复方乳酸钠注射液或滴速过快时, 可引起脑、肺、末梢水肿等副作用, 在使用时要密切注意。

(收稿: 2001-03-20 修回: 2001-08-07 编辑: 潘 达)

作者单位: 236300 安徽省阜南县中医院

普罗帕酮治疗室上性心动过速致不良反应 1 例

李正军

1 临床资料

患者, 女性, 27 岁。因胸闷、气短 3 小时入院。查体: 体温 36.2°C, 脉搏 160 次/分, 血压 140/75 mmHg (1 kPa = 7.5 mmHg)。神志清, 颈静脉无怒张, 两肺呼吸音清, 心尖听诊区可闻及 3/6 收缩期吹风样杂音及舒张期隆隆样杂音, 肝脾无肿大。心脏彩超示: 风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄伴关闭不全。心电图示: 室上性心

动过速。

住院后诊断与治疗: 诊断为风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄伴关闭不全, 并发阵发性室上性心动过速。给予吸氧, 心电监护, 含镁极化液稳定心肌细胞膜, 普罗帕酮转复心律, 剂量为 70 mg, 用 50% 葡萄糖液 20 ml 稀释静脉注射, 5 分钟后心电监护无改变, 重复使用 1 次, 共计普罗帕酮 140 mg, 约 5 分钟后心电监护示: 窦性心律, 心率 90 次/分, 随即病人突然感胸闷、心悸加重, 伴憋喘, 长出气, 大声呻吟, 偶咳白色泡沫粘痰, BP 110/75 mmHg, 痛

作者单位: 272204 山东省金乡县化雨乡中心卫生院